

BISOPROLOL Plus HCT 2.5/6.25

Đặc xa tầm tay trẻ em
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

(Cho 1 viên nén bao phim Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25)

Thành phần được chất:

Bisoprolol fumarate 2,5 mg

Hydrochlorothiazide 6,25 mg

Thành phần tá được:

Anhydrous calcium hydrogen phosphate, microcrystalline cellulose 102, pregelatinized starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, hypromellose 606, polyethylene glycol 6000, yellow ferric oxide, titanium dioxide, talc.

DẠNG BẢO CHẾ

Viên nén bao phim

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nén tròn, bao phim màu vàng, cạnh và thành viên lạnh lặn

CHỈ ĐỊNH

Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 được chỉ định để kiểm soát tình trạng tăng huyết áp.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Liệu pháp bisoprolol là phương pháp điều trị hiệu quả tăng huyết áp ở đây liều 2,5 mg đến 40 mg dùng một lần mỗi ngày, trong khi hydrochlorothiazide có hiệu quả ở đây liều 12,5 mg-50 mg.

Trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị kết hợp bisoprolol/hydrochlorothiazide khi sử dụng các liều kết hợp bisoprolol từ 2,5 mg đến 20 mg và liều hydrochlorothiazide từ 6,25 mg đến 25 mg, tác dụng hạ huyết áp tăng theo tỷ lệ thuận với tăng liều của từng thành phần.

Các tác dụng không mong muốn của bisoprolol là một hỗn hợp các hiện tượng phụ thuộc vào liều dùng (chủ yếu là nhịp tim chậm, tiêu chảy, suy nhược và mệt mỏi) và các hiện tượng độc lập với liều (ví dụ thỉnh thoảng phát ban) và của hydrochlorothiazide là một hỗn hợp các sự kiện phụ thuộc vào liều (chủ yếu là hạ potassium máu) và hiện tượng độc lập với liều (ví dụ có thể viêm tụy), hiện tượng phụ thuộc vào liều lượng xảy ra phổ biến hơn nhiều so với các hiện tượng độc lập với liều.

Phác đồ hướng dẫn điều trị theo đáp ứng lâm sàng

Bệnh nhân có huyết áp không kiểm soát được với các liều từ 2,5 mg - 20 mg bisoprolol hàng ngày có thể được thay thế vì kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide. Bệnh nhân có huyết áp được kiểm soát đầy đủ với liều 50 mg hydrochlorothiazide hàng ngày, nhưng mất potassium huyết đáng kể vì phác đồ này, có thể đạt được kiểm soát tương tự về huyết áp mà không có rối loạn chất điện giải nếu chuyển sang dùng kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide.

Trị liệu khởi đầu

Điều trị hạ huyết áp có thể được bắt đầu với liều thấp nhất của kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide 2,5 mg/6,25 mg (B/HCT) uống 1 viên mỗi ngày một lần. Sau điều chỉnh liều (cách quãng 14 ngày) có thể thử hiện tăng liều với viên kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide lên đến liều khuyến cáo tối đa 20 mg/12,5 mg (lúc hai lần liều 10 mg/6,25 mg) uống mỗi ngày một lần khi thích hợp.

Trị liệu thay thế

Sự kết hợp này có thể được thay thế cho các thành phần riêng lẻ khi cần tăng liều.

Ngưng trị liệu

Nếu muốn ngưng điều trị với bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide, cần lên kế hoạch để đạt được dần dần trong thời gian khoảng 2 tuần. Bệnh nhân phải được giám sát cẩn thận.

Bệnh nhân suy thận hoặc gan

Phải thận trọng khi sử dụng và điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan hoặc rối loạn chức năng thận. Vì không có dấu hiệu cho thấy hydrochlorothiazide có thể bị thẩm tách và có một số dữ liệu cho thấy bisoprolol không bị thẩm tách, không cần thiết thay thế thuốc ở bệnh nhân lọc thận.

Bệnh nhân cao tuổi

Liều dùng điều chỉnh trên cơ sở tuổi tác thường không cần thiết, trừ khi có rối loạn chức năng thận hoặc gan đáng kể. Trong các thử nghiệm lâm sàng có ít nhất 270 bệnh nhân được điều trị với bisoprolol fumarate kết hợp hydrochlorothiazide (HCT) có độ tuổi từ 60 trở lên. HCT làm tăng huyết đáng kể tác dụng hạ huyết áp của bisoprolol ở những bệnh nhân cao tuổi tăng huyết áp. Không có sự khác biệt tổng thể về hiệu quả hoặc an toàn được quan sát thấy giữa các bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi. Một báo cáo kinh nghiệm lâm sàng khác cho thấy không có sự khác biệt trong đáp ứng thuốc giữa các bệnh nhân cao tuổi và trẻ hơn, nhưng độ nhạy cảm của một số cá nhân lớn tuổi không thể loại trừ.

Bệnh nhân trẻ em

Không có dữ liệu đối với bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide.

Cách dùng

Thuốc dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Thuốc này chống chỉ định cho bệnh nhân có tình trạng sau:

- Sốc tim.
- Block nhĩ thất độ II hoặc III.
- Chậm nhịp xoang nặng.
- Vô niệu.
- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc hay với dẫn xuất sulfonamide khác.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Cảnh báo

Bisoprolol

Suy tim

Kích thích giao cảm là một thành phần cần thiết hỗ trợ chức năng tuần hoàn trong giai đoạn bắt đầu suy tim sung huyết, và suy chẹn beta có thể dẫn đến suy giảm chức năng bơm của cơ tim và thúc đẩy suy tim nặng hơn. Tuy nhiên, ở một số người bệnh có suy tim sung huyết còn bù có thể cần phải dùng thuốc này. Trong trường hợp này, phải dùng thuốc một cách thận trọng. Thuốc chỉ được dùng thêm cho đến khi đã có điều trị suy tim với các thuốc cơ bản (*thuốc lợi tiểu, digitalis, ức chế enzyme chuyển đổi*) dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa.

Bệnh nhân không có tiền sử suy tim từ trước

Trong một số bệnh nhân thuốc chẹn beta có thể tiếp tục gây suy yếu (chèn ép) cơ tim và thúc đẩy tình trạng suy tim. Dựa trên những dấu hiệu đầu tiên hoặc các triệu chứng của suy tim, cần xem xét việc ngừng bisoprolol fumarate và hydrochlorthiazide. Trong một số trường hợp, việc điều trị với bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide có thể được tiếp tục trong khi tình trạng suy tim được điều trị với các thuốc khác.

Ngưng điều trị đột ngột

Các đợt cấp của đau thắt ngực và trong một số trường hợp, nhồi máu cơ tim hoặc loạn nhịp tâm thất đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân bị bệnh động mạch vành xác định sau khi đột ngột ngừng điều trị với chẹn beta. Do đó những bệnh nhân này cần được cảnh báo không được giảm liều hoặc ngưng điều trị mà không có lời khuyên của bác sĩ. Ngay cả ở những bệnh nhân không có bệnh động mạch vành rõ ràng vẫn được khuyến khích điều trị giảm liều từ liều bisoprolol fumarate và hydrochlorthiazide khoảng hơn 1 tuần với liều điều kiện các bệnh nhân phải được theo dõi cẩn thận. Nếu xảy ra các triệu chứng vật vờ, cần tái lập điều trị bằng chẹn beta, ít nhất là tạm thời. Nếu các triệu chứng cai thuốc xảy ra, nên dùng thuốc lại ít nhất trong một thời hạn.

Bệnh mạch ngoại biên

Các thuốc chẹn beta có thể thúc đẩy hoặc làm nặng thêm các triệu chứng của chứng suy động mạch ở những bệnh nhân bị bệnh mạch máu ngoại vi. Cần thận trọng dùng thuốc đối với các bệnh nhân này.

Bệnh có thất phế quản

Nói chung bệnh nhân có bệnh có thất phế quản phổi không nên dùng thuốc chẹn beta. Vì có liên quan đến tính chẹn lọc beta, của bisoprolol fumarate nên kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide có thể được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có bệnh có thất phế quản phổi là những người không đáp ứng với thuốc hoặc những người không thể dùng nạp được các thuốc điều trị hạ huyết áp khác. Do tính chọn lọc beta, không tuyệt đối (tính chọn lọc giảm xuống khi tăng liều) nên cần sử dụng liều thấp nhất có thể của bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide. Tác dụng chủ yếu beta₂ (thuốc giãn phế quản) cũng có thể tạo hiệu lực.

Gây mê và đại phẫu thuật

Ở bệnh nhân điều trị dài hạn bằng thuốc chẹn beta, không nên ngừng thuốc trước khi thực hiện đại phẫu thuật. Tuy nhiên, khả năng tiến triển tim do phản ứng với phản xạ kích thích adrenergic có thể làm tăng rủi ro trong gây mê và đại phẫu thuật.

Đái tháo đường và hạ glucose huyết

Các thuốc chẹn beta có thể che lấp các biểu hiện của hạ glucose huyết, đặc biệt nhịp tim nhanh. Các thuốc chẹn beta không chọn lọc có thể làm tăng mức hạ glucose huyết gây bởi insulin và làm chậm sự phục hồi các nồng độ glucose huyết thanh. Do tính chất chọn lọc beta, điều này ít có khả năng xảy ra với bisoprolol fumarate. Tuy nhiên cần phải cảnh báo bệnh nhân hay bị hạ glucose huyết, hoặc bệnh nhân đái tháo đường đang dùng insulin hoặc các thuốc hạ glucose huyết uống về các khả năng này, và phải dùng bisoprolol một cách thận trọng.

Ngoài ra, đái tháo đường tiềm ẩn có thể trở thành bệnh tiểu hội hiện và bệnh nhân đái tháo đường do thiazide có thể yêu cầu điều chỉnh liều insulin của họ. Do liều lượng hydrochlorothiazide rất thấp nên điều này có thể ít có khả năng xảy ra với kết hợp bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide.

Nhiễm độc tuyến giáp

Suy chẹn beta-adrenergic có thể che lấp các dấu hiệu lâm sàng của tăng năng tuyến giáp (*cường giáp*), như nhịp tim nhanh. Việc ngừng đột ngột liệu pháp chẹn beta có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của cường giáp hoặc có thể thúc đẩy xảy ra cơn bão giáp.

Bệnh thận

Cần hiệu chỉnh liều bisoprolol một cách cẩn thận đối với bệnh nhân suy thận hoặc suy gan.

Tác động tích lũy của các thuốc có thể phát triển ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm. Ở những bệnh nhân này, thiazide có thể gây ra chứng nư huyết. Người bệnh có dự thanh thời creatinin khoảng 40 ml/phút, thời gian bán thải trong huyết tương của bisoprolol fumarate tăng lên đến gần ba lần so với người khỏe mạnh. Nếu suy thận tiến triển trở nên rõ ràng cần ngưng thuốc bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide.

Bệnh gan

Bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide nên sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có chức năng gan suy giảm hoặc bệnh gan tiến triển. Thiazide có thể làm thay đổi cân bằng dịch và điện giải, có thể gây hôn mê gan. Ngoài ra, việc thay

trừ bisoprolol fumarate chậm hơn đáng kể ở những bệnh nhân bị xơ gan so với người khỏe mạnh.

Hydrochlorothiazide

Cận thị cấp tính và tăng nhãn áp góc đóng thu phát (glaucom)

Hydrochlorothiazide, một sulfonamide, có thể gây ra phản ứng mang đặc thù riêng, dẫn đến cận thị cấp tính thoáng qua và tăng nhãn áp cấp tính góc đóng. Các triệu chứng bao gồm khởi phát cấp tính cơn đau đầu thị lực hoặc hình ảnh và thường xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần khi bắt đầu dùng thuốc. Chứng tăng nhãn áp góc đóng nên được ngưng thuốc điều trị có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Việc điều trị chủ yếu là ngưng hydrochlorothiazide càng nhanh càng tốt. Phương pháp điều trị hoặc phẫu thuật có thể cần phải được xem xét nếu áp lực nội nhãn vẫn không kiểm soát được. Các yếu tố nguy cơ cho phát triển cấp góc đóng bệnh tăng nhãn áp có thể bao gồm có tiền sử dùng sulfonamide hoặc ử dụng penicillin.

Tiền trọng

Tình trạng cân bằng dịch và chất điện giải

Mặc dù xác suất phát triển chứng hạ potassium máu là hạn chế với bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide (HCT) vì liều rất thấp của HCT, nhưng nên định kỳ xác định chất điện giải trong huyết thanh và bệnh nhân phải được theo dõi các dấu hiệu về thể dịch hoặc rối loạn điện giải, tức là, hạ sodium máu, nhiễm kiềm giả chloride huyết (*hypochloremic*), hạ potassium máu và giảm magnesium huyết (*hypomagnesemia*). Thiazide cho thấy có sự tăng bài tiết magnesium qua nước tiểu, điều này có thể gây ra kết quả là làm giảm magnesium huyết (*hypomagnesemia*).

Dù vậy bất kỳ sự thiếu hụt lon chloride nào xảy ra thường là nhẹ và không cần điều trị cụ thể, ngoại trừ các trường hợp khác thường (như trong bệnh gan hoặc bệnh thận) việc thay thế chloride có thể được yêu cầu trong điều trị nhiễm kiềm chuyển hóa. Đau đầu chân đau hoặc triệu chứng mất cân bằng dịch và chất điện giải bao gồm khô miệng, khát nước, suy yếu, yếu cổ, buồn ngủ, bồn chồn, da có hoặc chuột rút, mỏi cơ bắp, hạ huyết áp, thiếu niệu, nhịp tim nhanh và các rối loạn tiêu hóa như buồn nôn và nôn.

Hạ potassium máu có thể phát triển, đặc biệt là với lợi tiểu nhanh khi đang bị xơ gan nghiêm trọng, trong quá trình sử dụng đồng thời với corticosteroid hoặc nội tiết tố vỏ thượng thận (ACTH) hoặc sau khi điều trị kéo dài. Uống một lượng đầy đủ các chất điện giải cũng sẽ góp phần hạ potassium máu. Hạ potassium máu và giảm magnesium máu có thể gây loạn nhịp tâm thất hoặc tăng nhạy cảm hoặc làm tăng qua mức đáp ứng của tim với các tác động độc hại của digitalis. Hạ potassium máu có thể tránh được hoặc điều trị bổ sung potassium hoặc tiêu thụ gia tăng các thực phẩm giàu potassium. Hạ sodium huyết do pha loãng có thể xảy ra ở bệnh nhân bị phù trong thời tiết nóng, điều trị thích hợp là hạn chế nước chứ không phải là bổ sung muối, ngoại trừ trường hợp hạ sodium máu đe dọa đến tính mạng (*hiểm*). Trong trường hợp mất muối, sự lưa chon thích hợp là thay thế liệu pháp.

Chứng tăng acid uric máu

Tăng acid uric máu hoặc bệnh gout cấp tính có thể xảy ra ở một số bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu thiazide. Bisoprolol fumarate, dùng một mình hoặc kết hợp với HCT, đều có liên quan tới chứng tăng acid uric. Tuy nhiên trong các thử nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc phải chứng tăng acid uric liên quan đến điều trị ở liều hydrochlorothiazide (HCT) 25 mg (25%) lớn hơn so với B/HCT 6,25 mg (10%). Vì liều lượng rất thấp của HCT nên chứng tăng acid uric máu có thể ít có khả năng xảy ra với kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide.

Tăng đường huyết

Tăng đường huyết có thể xảy ra với thuốc lợi tiểu thiazide. Do đó bệnh đái tháo đường tiềm ẩn có thể biểu lộ ra khi điều trị với thiazide.

Các tác dụng khác

Các tác dụng hạ huyết áp của thuốc có thể gia tăng ở bệnh nhân phẫu thuật cắt bỏ thần kinh giao cảm.

Bệnh tuyến cận giáp

Thiazide làm giảm bài tiết calcium và làm thay đổi bệnh lý của các tuyến cận giáp, chứng tăng calcium huyết và giảm phosphate huyết đã được quan sát thấy ở một vài bệnh nhân điều trị bằng thiazide kéo dài. Thiazide có thể gây ra các đợt tăng liên tục và nhẹ calcium huyết thanh trong trường hợp không có các rối loạn chuyển hóa calcium. Bệnh nhân cho chúng tăng calcium huyết có thể là bằng chứng của cường cận giáp ẩn. Thiazide nên ngưng trước khi thực hiện việc kiểm tra chức năng tuyến cận giáp. Sự gia tăng nồng độ cholesterol và chất béo trung tính có thể có liên quan đến thuốc lợi tiểu thiazide.

Suy thận

Nếu suy thận tiến triển trở nên rõ ràng, cần xem xét giảm liều thuốc không tiếp tục điều trị bằng thuốc lợi tiểu. Thiazide đã được chứng minh là làm tăng sự bài tiết magnesium nước tiểu, điều này có thể dẫn đến chứng giảm magnesium huyết (*hypomagnesemia*).

Thiazide nên được sử dụng thận trọng trong bệnh thận nặng. Ở những bệnh nhân bị bệnh thận, thiazide có thể gây chứng urea-huyết.Tác động tích lũy của thuốc có thể phát triển ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Thiazide qua được hàng rào nhau thai và xuất hiện trong máu dây rốn. Việc sử dụng các thiazide ở phụ nữ mang thai đối với dự đoán được lợi ích so với các nguy cơ có thể cho thai nhi. Những mối nguy hiểm này bao gồm gây vàng da cho bào thai hoặc trẻ sơ sinh, viêm tụy, giảm tiểu cầu và có thể có thể có phản ứng bất lợi khác đã xảy ra ở người lớn.

Phụ nữ cho con bú

Bisoprolol fumarate dùng đơn trị hoặc kết hợp với HCT đã không được nghiên cứu ở các bà mẹ đang nuôi con bú. Thiazide được bài tiết qua sữa mẹ. Một lượng nhỏ của bisoprolol fumarate (< 2% liều dùng) đã được phát hiện trong sữa của những con bú tiết cống cho con bú. Do tiềm năng gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng khi điều dưỡng trẻ sơ sinh, việc quyết định ngưng cho con bú hoặc ngưng thuốc nên tính đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Kinh nghiệm cho thấy việc điều trị không làm ảnh hưởng khả năng lái xe hay sử dụng máy móc của bệnh nhân. Tuy nhiên một số phản ứng bất lợi như chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra; do đó có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

Bisoprolol fumarate (B) và Hydrochlorothiazide (HCT)

Bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide có thể làm tăng tác dụng của các thuốc hạ huyết áp khác khi dùng đồng thời. Bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide không nên dùng kết hợp với chất chẹn beta khác. Bệnh nhân dùng thuốc làm suy giảm/liều hao catecholamine, chẳng hạn như reserpine hoặc guanethidine, nên được giám sát chặt chẽ vì tác dụng chẹn beta-adrenergic tăng thêm có thể gây giảm quá mức hoạt tính giao cảm. Ở những bệnh nhân được điều trị đồng thời với clonidine, nếu cần phải ngưng điều trị thì nên ngưng dùng bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide vài ngày trước khi ngưng dùng clonidine.

Bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide nên thận trọng khi dùng chung với các thuốc ức chế cơ bóp cơ bóp cơ tim hoặc ức chế sự dẫn truyền nhĩ-thất hoặc thuốc trể tâm, chẳng hạn như thuốc đối kháng calcium xác định (đặc biệt thuốc các nhóm phenylalkylamine (verapamil) và benzothiazepine [diltiazem]) hoặc các thuốc chống loạn nhịp, chẳng hạn như disopyramide. Cả hai chất digitalis glycosides và chẹn beta làm chậm dẫn truyền nhĩ thất và nhịp tim giảm. Sử dụng đồng thời có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim chậm.

Bisoprolol fumarate

Sử dụng đồng thời với rifampin làm tăng độ thanh thải của bisoprolol fumarate, rút ngắn thời gian bán thải. Tuy nhiên, không cần thiết phải thay đổi liều khởi đầu.

Tài liệu nghiên cứu về việc động học không cho thấy có tương tác lâm sàng liên quan tới các chất dùng đồng thời khác, bao gồm cả thuốc lợi tiểu thiazide và cimetidine. Bisoprolol fumarate không có ảnh hưởng lên thời gian prothrombin ở những bệnh nhân dùng liều warfarin ổn định.

Nguy cơ phản ứng phân vờ: Trong khi dùng thuốc chẹn beta, bệnh nhân có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với các dị nguyên khác nhau có thể có phản ứng mạnh hơn với việc sử dụng thuốc khác lại hoặc do tình cơ hoặc do điều trị. Những bệnh nhân này có thể không đáp ứng với liều epinephrine thường dùng để điều trị các phản ứng dị ứng.

Hydrochlorothiazide

Khi được dùng đồng thời với các thuốc sau đây có thể có tương tác với thuốc lợi tiểu thiazide bao gồm nư, thuốc an thần hoặc thuốc ngủ gây nghiện: Có thể xảy ra tăng liều của thuốc hạ huyết áp thế dùng.

Thuốc trị đái tháo đường (thuốc uống và insulin): Cần điều chỉnh liều lượng của thuốc trị đái tháo đường do tăng glucose huyết.

Thuốc hạ huyết áp khác: Có thể xảy ra tác dụng hiệp đồng hoặc tăng thêm lọc hạ huyết áp.

Cholestyramine và nhựa colestipol: Sự hấp thụ của hydrochlorothiazide bị suy giảm khi có sự hiện diện của các loại nhựa trao đổi anion như trên. Liều duy nhất của nhựa cholestyramine và colestipol gắn kết với hydrochlorthiazide và làm giảm độ hấp thụ ở đường tiêu hóa đến 85% và 43%, tương ứng.

Corticosteroid, ACTH: Làm tăng sự cân kiệt chất điện giải, đặc biệt là giảm potassium máu.

Amine (ví dụ norepinephrine): Có thể làm giảm đáp ứng với các amine tăng huyết áp nhưng không đủ để ngăn cản việc sử dụng chúng.

Thuốc giãn cơ xương, nhóm không chủ cực (ví dụ, tubocurarine): Có thể tăng đáp ứng với các thuốc giãn cơ.

Lithium: Không nên dùng cùng với thuốc lợi tiểu. Các thuốc lợi tiểu làm giảm độ thanh thải thận của lithium và gây ra nguy cơ cao bị ngộ độc lithium. Hay tham khảo từ hướng dẫn sử dụng của các chế phẩm lithium trước khi sử dụng bisoprolol fumarate và hydrochlorthiazide.

Thuốc chống viêm không steroid: Trong một số bệnh nhân, khi uống thuốc chống viêm không steroid có thể làm giảm tác dụng lợi tiểu, giảm bài tiết sodium niệu và giảm tác dụng hạ huyết áp của thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc lợi tiểu tiết kiệm potassium. Vì vậy, khi dùng thuốc chống viêm không steroid dùng đồng thời với các thuốc chống viêm không steroid, bệnh nhân cần được giám sát chặt chẽ để xác định mức hiệu quả mong muốn của thuốc lợi tiểu.

Khi dùng thiazide, phản ứng nhạy cảm có thể xảy ra ở các bệnh nhân có thể hoặc không có tiền sử dị ứng hoặc hen phế quản. Phản ứng nhạy cảm với ánh sáng và có thể làm tăng nặng thêm hoặc khởi phát lupus ban đỏ liên sản đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng thiazide. Tác dụng hạ huyết áp của thiazide có thể gia tăng ở bệnh nhân sau khi cắt bỏ thần kinh giao cảm.

Xét nghiệm

Đưa trên các báo cáo liên quan đến thiazide, bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide có thể làm giảm nồng độ lode gắn kết với protein huyết thanh nhưng không cho dấu hiệu của sự rối loạn tuyến giáp. Do thuốc kết hợp có chứa thiazide (hydrochlorthiazide) nên ngưng dùng thuốc trước khi thực hiện kiểm tra chức năng tuyến cận giáp.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)

Kết hợp bisoprolol fumarate (B) và hydrochlorthiazide (HCT)

Liều kết hợp bisoprolol fumarate/hydrochlorthiazide (HCT) 6,25 mg được dùng quan tốt ở hầu hết các bệnh nhân. Hầu hết các tác dụng không mong muốn (*AEs: Adverse effects*) đều nhẹ và thoáng qua. Trong số hơn 65.000 bệnh nhân được điều trị trên toàn thế giới với thuốc bisoprolol fumarate, hiếm gặp xuất hiện phản ứng có thất phế quản. Tỷ lệ ngưng do AEs tương tự nhau ở những bệnh nhân dùng liều kết hợp bisoprolol fumarate/HCT 6,25 mg và những bệnh nhân dùng liều đơn.

Tại Hoa Kỳ, có 252 bệnh nhân được cho dùng các liều bisoprolol fumarate (2,5 mg, 5 mg, 10 mg hoặc 40 mg) kết hợp với HCT 6,25 mg và có 144 bệnh nhân dùng liều đơn được trong hai thử nghiệm đối chứng. Ở nghiên cứu 1, liều kết hợp bisoprolol fumarate 5 mg/HCT 6,25 mg được cho dùng trong 4 tuần. Ở nghiên cứu 2, các liều kết hợp bisoprolol fumarate 2,5 mg, 10 mg hoặc 40 mg/HCT 6,25 mg được cho dùng trong 12 tuần.



Tất cả các tác dụng không mong muốn xảy ra, có hoặc không liên quan đến thuốc và các tác dụng không mong muốn xảy ra ở các bệnh nhân được điều trị với các liều bisoprolol fumarate 2,5 mg - 10 mg/HCT 6,25 mg được báo cáo so sánh với thời gian điều trị 4 tuần có tần suất < 2% so với liều bisoprolol fumarate/HCT 6,25 mg của các bệnh nhân đã được điều trị (cùng thời gian các tác dụng không mong muốn) bao gồm:

Tim mạch: Nhịp tim chậm/loạn nhịp tim/thiếu máu cục bộ ngoại vi/đau ngực.

Hô hấp: Có thất phế quản/ho/viêm mũi/nhiễm trùng đường hô hấp trên (URI, *Upper Respiratory Infection* or *Common cold*).

Toàn thân: Suy nhược/mệt mỏi/phù thân kinh ngoại vi.

Hệ thần kinh trung ương: Chóng mặt/đau đầu.

Cơ xương khớp: Chuột rút cơ bắp/đau cơ.

Tâm thần: Mất ngủ/buồn ngủ/mất ham muốn tình dục/bất lực.

Hô tiêu hóa: Tiêu chảy/buồn nôn/rối loạn tiêu hóa.

Nhiều tác dụng không mong muốn khác được báo cáo theo thành phần kết hợp được liệt kê dưới đây.

Bisoprolol fumarate

Bisoprolol được dùng nạp tốt ở phần lớn người bệnh. Phần lớn các tác dụng không mong muốn ở mức độ nhẹ và nhất thời. Tỷ lệ người bệnh phải ngừng điều trị do các tác dụng không mong muốn là 3,3% đối với người bệnh dùng bisoprolol và 6,8% đối với bệnh nhân dùng placebo.

Trong các thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới hoặc kinh nghiệm sau khi đưa thuốc ra thị trường, một loạt các tác dụng không mong muốn (AEs) khác, ngoài các tác dụng không mong muốn đã được liệt kê ở trên, đã được báo cáo. Trong khi ở nhiều trường hợp cho thấy có phải là mối quan hệ nhân quả tồn tại giữa bisoprolol và những AEs hay không, nhưng vẫn được liệt kê để cảnh báo cho bác sĩ về mối quan hệ có thể có.

Hệ thần kinh trung ương: Đờ đẫn không vững, chóng mặt, chóng mặt, nhức đầu, ngất xỉu, dị cảm, giảm cảm giác (hypoesthesia), tăng cảm giác (hyperesthesia), rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ gà, trầm cảm, lo lắng/bồn chồn, giảm trí nhớ.

Tim mạch: Chậm nhịp tim, đánh trống ngực và rối loạn nhịp khác, tụt chi lạnh, đau cơn không đều (*claudication*), hạ huyết áp, hạ huyết áp tư thế, đau ngực, suy tim sung huyết, khó thở khi gắng sức.

Đường tiêu hóa: Đau dạ dày/đau vùng thượng vị/đau bụng, loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, khó tiêu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón, khô miệng.

Cơ xương khớp: Đau khớp, đau cơ bắp/đau khớp, đau lưng/đau cơ, chuột rút cơ bắp, co giật/run.

Dạ Phôi ban, mụn trứng cá, chàm (eczema), bệnh vẩy nến, kích ứng da, ngứa, ban xuất huyết, đỏ bừng mặt, vảy mủi, rụng tóc, viêm da, viêm da tróc (rối viêm), viêm mạch da.

Giác quan đặc biệt: Rối loạn thị giác, mất da/nhân áp, chảy nước mắt bất thường, ù tai, giảm thính lực, đau tai, vị giác bất thường.

Trào ngược chất: Bệnh gout.

Hô hấp: Hen suyễn, có thất phế quản, viêm phế quản, khó thở, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, URI (nhiễm trùng đường hô hấp trên).

Sinh dục: Giảm ham muốn tình dục/bất lực, bệnh Peyronie rối loạn ở dương vật rất hiếm, viêm bạch quang, đau thần tưng cẳng (*renal colic*), tiểu nhiều.

Tổng quát: Mệt mỏi, suy nhược, đau ngực, khó chịu, phù, tăng cân, phù mạch.

Hydrochlorothiazide

Các tác dụng không mong muốn, ngoài những tác dụng được liệt kê ở trên, đã được báo cáo với hydrochlorothiazide (thông thường với liều 25 mg hoặc cao hơn).

Tổng quát: Suy yếu.

Hệ thần kinh trung ương: Chóng mặt, dị cảm, bồn chồn.

Tim mạch: Hạ huyết áp tư thế (có thể tăng do dùng rượu, các loại thuốc an thần hoặc các chất gây nghiện).

Đường tiêu hóa: Biếng ăn, kích thích dạ dày, có thất, táo bón, vàng da (vàng da ứ mật), viêm ruột, viêm túi mật, viêm tuyến nước bọt (sialadenitis), khô miệng.

Cơ xương khớp: Có thất cơ bắp.

Phản ứng quá mẫn: Ban xuất huyết, nhạy cảm với ánh sáng, phát ban, mày đay, viêm mạch huyết tử (viêm mạch, viêm mạch da), sốt, suy hô hấp bao gồm cả phù nề, viêm phổi và phù phổi, phản ứng phản vệ.

Giác quan đặc biệt: Thoáng mắt mờ mắt, chóng trắng lóa vàng (nhìn hóa vàng, xanthopsia).

Trào ngược chất: Bệnh gout.

Sinh dục: Rối loạn chức năng tình dục, suy thận, rối loạn chức năng thần, viêm thận kẽ.

Dạ Ban đỏ da dạng bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, viêm da tróc bao gồm hoại tử biểu bì nhiễm độc.

Các bất thường ở phòng thí nghiệm

Bisoprolol fumarate (B) và hydrochlorothiazide (HCT)

Do liều lượng thuốc của hydrochlorothiazide trong kết hợp bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide (HCT) nên các tác dụng không mong muốn về trao đổi chất của bisoprolol fumarate/HCT 6,25 mg ít gặp hơn và có tự nhỏ hơn so với HCT 25 mg. Ở liều phòng thí nghiệm trên potassium huyết thanh từ các thử nghiệm có kiểm soát với giả được ở Mỹ được thể hiện trong bảng sau đây:

Ở liều potassium huyết thanh từ các nghiên cứu có kiểm soát với giả được ở Mỹ					
Potassium	Giả được*	82,5/H 6,25 mg	85/H 6,25 mg	810/H 6,25 mg	HCT 25 mg*
	(N=130 ^b)	(N=28 ^b)	(N=149 ^b)	(N=28 ^b)	(N=142 ^b)
Trung bình thay đổi ^c (mEq/L)	+0,04	+0,11	-0,08	0,00	-0,30%
Hạ potassium máu ^d	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	5,5%
a) Nghiệm cứu kết hợp chéo. b) Bệnh nhân với potassium huyết thanh bình thường tính theo đường cơ bản. c) Trung bình thay đổi tính từ đường cơ bản ở tuần thứ 4. d) Phần trăm bệnh nhân có bất thường ở tuần thứ 4. B (Bisoprolol fumarate) – H (Hydrochlorothiazide)					

Điều trị với cả 2 thuốc chẹn beta và thuốc lợi tiểu thiazide có liên quan tới sự gia tăng acid uric. Tuy nhiên, lâm quan trong của sự thay đổi ở những bệnh nhân được điều trị với bisoprolol fumarate/HCT 6,25 mg là thấp hơn ở những bệnh nhân được điều trị với HCT 25 mg. Sự gia tăng trung bình các chất béo trong tính huyết thanh đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị với bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide 6,25 mg. Tổng số cholesterol nội chung không bị ảnh hưởng, nhưng có sự giảm nhẹ lượng cholesterol HDL đã được ghi nhận.

Các xét nghiệm bất thường khác được báo cáo theo từng các thành phần được liệt kê dưới đây:

Bisoprolol fumarate

Trong thử nghiệm lâm sàng các thay đổi chỉ số thường xuyên nhất trong phòng thí nghiệm là sự gia tăng các chất béo trung tính trong huyết thanh, nhưng điều này không nhất quán được báo cáo. Theo kinh nghiệm của Mỹ các thử nghiệm có đối chứng với liều điều trị bisoprolol fumarate trong 4-12 tuần, tỷ lệ tăng cao đồng thời trong SGOT và SGPT gấp từ 1 đến 2 lần mức bình thường là 3,9% so với 2,5% của giả được. Không có bệnh nhân nào có mức cao đồng thời gấp hơn 2 lần mức bình thường.

Kinh nghiệm sử dụng lâu dài không kiểm soát khi điều trị với bisoprolol fumarate trong 6-18 tháng, tỷ lệ mắc phải của một hoặc đồng thời nhiều mức cao trong chỉ số SGOT và SGPT gấp từ 1 đến 2 lần mức bình thường là 6,2%. Tỷ lệ thường xuất hiện là 1,9%. Đối với mức cao đồng thời của SGOT và SGPT lớn hơn 2 lần mức bình thường, tỷ lệ mắc là 1,5%. Tỷ lệ xuất hiện nhiều là 0,3%. Trong nhiều trường hợp mức cao là do rối loạn tiềm ẩn hoặc giả thuyết được qua trình tiếp tục điều trị với bisoprolol fumarate.

Các thay đổi chỉ số khác ở phòng thí nghiệm bao gồm sự gia tăng nhẹ trong acid uric, creatinine, BUN (blood urea nitrogen hoặc serum creatinine), potassium huyết thanh, glucose và phospho, giảm bạch cầu và tiểu cầu. Đã có báo cáo thường xuyên của tăng bạch cầu ái toan. Đây là những thay đổi thường không quan trọng và hiếm khi dẫn đến sự ngưng dùng bisoprolol fumarate. Cũng như các thuốc chẹn beta khác, bisoprolol fumarate cũng gây ra những thay đổi trong xét nghiệm kháng thể kháng nhân (*ANA: Antinuclear Antibody*). Khoảng 15% bệnh nhân trong những nghiên cứu dài hạn có kết quả dương tính, mặc dù khoảng 1/3 trong số những bệnh nhân này chuyển thành âm tính khi tiếp tục điều trị.

Hydrochlorothiazide (HCT)

Tăng đường huyết, đường niệu, tăng acid uric máu, hạ potassium máu và sự mất cân bằng điện giải (*xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*), tăng lipid máu, chứng tăng calcium huyết, giảm bạch cầu, mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, thiếu máu bất sản, thiếu máu tán huyết có liên quan đến liệu pháp HCT.

Hướng dẫn cách xử trí ADR:

Khi xảy ra ADR với các biểu hiện trên, có thể xử trí như các trường hợp của triệu chứng quá liều (*xem mục: Quá liều và cách xử trí*).

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Hiện có ít thông tin về quá liều với bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide. Tuy nhiên, một số trường hợp quá liều với bisoprolol fumarate đã được báo cáo (tối đa: 2000 mg). Chậm nhịp tim và/hoặc tụt huyết áp đã được ghi nhận. Thuốc cường giao cảm đã được dùng trong một số trường hợp và tất cả các bệnh nhân đều hồi phục.

Các dấu hiệu thường xuyên dự kiến quan sát với quá liều thuốc chẹn beta là chậm nhịp tim và hạ huyết áp. Tình trạng ngủ lịm cũng phổ biến và với quá liều nghiêm trọng sẽ bị mê sảng, hôn mê, co giật và ngừng hô hấp đã được báo cáo xảy ra. Suy tim sung huyết, có thất phế quản và hạ đường huyết có thể xảy ra, đặc biệt là ở những bệnh nhân đang có sẵn các bệnh ở các cơ quan này. Với các thuốc lợi tiểu thiazide, nhiễm độc cấp tính rất hiếm xảy ra. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của quá liều là gây mất dịch lỏng và chất điện giải cấp tính. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm tim mạch (tim đập nhanh, hạ huyết áp, sốc), thần kinh (yếu ớt, lú lẫn, chóng mặt, chuột rút cơ bắp chân, dị cảm, mệt mỏi, suy giảm ý thức), tiêu hóa (buồn nôn, nôn, khát nước), thần (tiểu nhiều, thiếu niệu hoặc vô niệu (gây ra do hemoconcentration)) và các thay đổi kết quả xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (hạ potassium máu, hạ sodium máu, giảm chloride máu (hypochloremia), nhiễm kiềm, tăng nitrogen urea huyết (BUN, Blood Urea Nitrogen) (đặc biệt ở những bệnh nhân suy thận)) và mất nước do lợi tiểu quá mức. Liều uống LD₅₀ của hydrochlorothiazide lớn hơn 10g/kg cho cả hai loài chuột nhắt và chuột cống.

Nếu nghi ngờ có quá liều bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide thì nên ngưng việc điều trị và bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ vì không có thuốc giải độc đặc biệt. Một số dữ liệu hạn chế gợi ý bisoprolol fumarate không thể bị thẩm tách, tương tự như vậy cũng không có dấu hiệu cho thấy hydrochlorothiazide có thể bị thẩm tách. Các biện pháp để ngăn chặn bao gồm gây nôn và/hoặc rửa dạ dày, uống than hoạt tính, hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh sự mất cân bằng dịch lỏng và chất điện giải và điều trị co giật. Cần có vào các tác động được lý học dự kiến và khuyến cáo cho thuốc chẹn beta khác và hydrochlorothiazide, các biện pháp sau đây cần được xem xét khi thực hiện lâm sàng:

Nhịp tim chậm

Tiêm tĩnh mạch atropine. Nếu đáp ứng chưa đạt, có thể dùng tim trong isoproterenol hoặc một thuốc khác có tác dụng làm tăng, điều nhịp (*chronotropic*) tích cực. Trong một số trường hợp, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời để kích thích tăng nhịp.

Hạ huyết áp, sốc

Bệnh nhân khi nằm tư thế các chân nên được nâng lên. Truyền dịch tĩnh mạch để điều chỉnh cân bằng dịch lỏng và chất điện giải bị mất (potassium, sodium). Có thể cần tiêm tĩnh mạch glucagon hoặc một thuốc chủ vận alpha-adrenergic.

Biến tim (mức độ thất hoặc thứ ba)

Bệnh nhân cần được theo dõi cẩn thận và được điều trị bằng dịch truyền isoproterenol hoặc đặt máy tạo nhịp tim, nếu thích hợp.

Suy tim sung huyết

Bắt đầu thuốc chẹn các biến pháp điều trị thông thường (tức là dùng digitalis, thuốc lợi tiểu, thuốc làm giãn mạch, làm tăng cơ co bóp cơ tim).

Có thất phế quản

Dùng một thuốc giãn phế quản như isoproterenol và/hoặc aminophylline.

Hạ đường huyết

Tiêm tĩnh mạch glucose.

Giảm sát y tế

Cần bằng chất lỏng và chất điện phân (đặc biệt là huyết thanh potassium) và chức năng thận phải được theo dõi cho đến khi bình thường hóa.

DƯỢC LỰC HỌC

Nhiệm được lý: Thuốc chẹn beta kết hợp với thiazide.

Mã ATC: C07B B07

Bisoprolol fumarate (B) kết hợp Hydrochlorothiazide (HCT)

Bisoprolol fumarate (B) và Hydrochlorothiazide (HCT) đã được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp để điều trị tăng huyết áp. Tác dụng hạ huyết áp của các hoạt chất này là hiệp lực; HCT 6,25 mg làm tăng đáng kể tác dụng hạ huyết áp của bisoprolol fumarate. Tỷ lệ hạ potassium máu của kết hợp bisoprolol fumarate và HCT 6,25 mg (B/H) thấp hơn đáng kể so với HCT 25 mg. Trong các thử nghiệm lâm sàng của bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide, mức trung bình huyết áp tối thiểu đáng kể hoặc không có huyết thanh ở bệnh nhân được điều trị với kết hợp bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide 2,5 mg/6,25 mg, 5 mg/6,25 mg, 10 mg/6,25 mg hoặc giả được ít hơn ± 0,1 mEq/L. Mức trung bình thay đổi hàm lượng potassium trong huyết thanh của các bệnh nhân được điều trị với bất kỳ liều bisoprolol kết hợp với HCT 25 mg làm thay đổi từ -0,1 đến -0,3 mEq/L. Bisoprolol fumarate là một thuốc chẹn chọn lọc beta, (cardioselective) không có tính ổn định màng đáng kể hoặc không có tác dụng giống thần kinh giao cảm nội tại trong phạm vi liều điều trị. Ở liều cao (> 20 mg), bisoprolol fumarate cũng có thể gây tăng, nằm ở hệ cơ phế quản và mạch máu. Để giữ được tính chọn lọc tương đối, điều quan trọng là sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả.

Hydrochlorothiazide là một thuốc lợi tiểu nhóm benzothiadiazine. Thiazide ảnh hưởng đến cơ chế ống thận của tái hấp thu chất điện giải và làm tăng bài tiết sodium và chloride với lượng gần tương đương nhau. Tình trạng sodium niệu (*sodiumuresis*) sẽ gây ra mất potassium tái cấp.

Bisoprolol

Bisoprolol là một thuốc chẹn chọn lọc beta; (β₁) nhưng không có tính chất ổn định màng và không có tác dụng giống thần kinh giao cảm nội tại khi dùng trong phạm vi liều điều trị. Với liều thấp, bisoprolol có thể chọn lọc đáp ứng với kích thích adrenaline bằng cách cạnh tranh chẹn thụ thể β₁ adrenaline của tim, nhưng ít tác dụng trên thụ thể beta₂ (β₂) adrenaline của cơ trơn phế quản và thành mạch. Với liều cao (thử dụ 20 mg hoặc cao hơn), tính chất chọn lọc của bisoprolol trên thụ thể β₁ thường giảm xuống và thuốc sẽ cạnh tranh ở chế cả hai thụ thể β₁ và β₂.

Bisoprolol được dùng để điều trị tăng huyết áp. Hiệu quả của bisoprolol tương đương với các thuốc chẹn beta khác. Có chế tác dụng hạ huyết áp của bisoprolol có thể gồm những yếu tố sau: Giảm lưu lượng tim, do chế thận giải phóng renine và giảm tác động của thần kinh giao cảm đi từ các trung tâm vận mạch ở não. Nhưng tác dụng nổi bật nhất của bisoprolol là làm giảm tần số tim, có lúc nghĩ lẫn lo lắng sức. Bisoprolol làm giảm lưu lượng của tim nghỉ và khi gắng sức, kèm theo ít thay đổi về thể tích máu tổng ra trong mỗi nhát bóp tim, và chỉ làm tăng ít áp lực nhĩ phải hoặc áp lực mao mạch phổi bất lực nghỉ và khi gắng sức. Từ khi có chứng chỉ định hoặc nghi ngờ không dùng nạp được, thuốc chẹn beta đã được dùng phối hợp với chế enzyme chuyển, lợi tiểu và glycoside trợ tim để điều trị suy tim mạn sung huyết được cho chủ yếu là do ức chế các tác động của hệ thần kinh giao cảm. Dùng thuốc chẹn beta lâu dài, cũng như các thuốc ức chế enzyme chuyển đổi, có thể làm giảm các triệu chứng suy tim và cải thiện tình trạng lâm sàng của người bị suy tim mạn. Các tác dụng tốt này đã được chứng minh ở người đang dùng một thuốc ức chế enzyme chuyển, cho thấy ức chế phối hợp hệ thống renin-angiotensin và hệ thần kinh giao cảm là các tác dụng cộng.

Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazide và các thuốc lợi tiểu thiazide làm tăng bài tiết sodium chloride và nước kèm theo do cơ chế ức chế tái hấp thu các ion sodium và chloride ở ống lượn xa. Sự bài tiết các chất điện giải khác cũng tăng đặc biệt là potassium và magnesium, còn calcium thì giảm.

Hydrochlorothiazide cũng làm giảm hoạt tính enzyme anhydrase carbonic nên làm tăng bài tiết bicarbonate nhưng tác dụng này thường nhỏ so với tác dụng bài tiết Cl⁻ và không làm thay đổi đáng kể pH nước tiểu. Các thiazide có tác dụng lợi tiểu mức độ vừa phải, vì khoảng 90% ion sodium đã được tái hấp thu trước khi đến ống lượn xa là vị trí chủ yếu thuốc có tác dụng.

Hydrochlorothiazide có tác dụng hạ huyết áp, trước tiên có lẽ do giảm thể tích huyết tương và dịch ngoại bào liên quan đến sự bài niệu sodium. Sau đó trong quá trình dùng thuốc, tác dụng hạ huyết áp tùy thuộc vào sự giảm sức cản ngoại vi, thông qua sự thích nghi dần của các mạch máu trước tình trạng gia tăng dòng do Na⁺. Vì vậy, tác dụng hạ huyết áp của hydrochlorothiazide thể hiện chậm sau 1 - 2 tuần, còn tác dụng lợi tiểu xảy ra nhanh có thể thấy ngay sau vài giờ.

Hydrochlorothiazid làm tăng tác dụng của các thuốc hạ huyết áp khác.

DƯỢC ĐỒNG HẠC

Bisoprolol fumarate (B) kết hợp Hydrochlorothiazide (HCT)

Ở người tình nguyện khỏe mạnh, cả hai chất bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide đều được hấp thu tốt sau khi uống.

Không thấy có sự thay đổi sinh khả dụng của mỗi chất khi uống chung với nhau trong cùng một viên thuốc với các liều thử.

Sự hấp thu của bisoprolol fumarate và hydrochlorothiazide không bị ảnh hưởng do dùng chung với thức ăn hay không. Nồng độ đỉnh trong bình trong huyết tương của bisoprolol fumarate khoảng 9 ng/mL, 19 ng/mL và 36 ng/mL xảy ra khoảng 3 giờ sau khi uống các liều 2,5 mg/6,25 mg, 5 mg/6,25 mg và 10 mg/6,25 mg của viên kết hợp, tương ứng. Nồng độ đỉnh trong bình trong huyết tương của hydrochlorothiazide đạt 30 ng/mL xảy ra khoảng 2,5 giờ sau khi uống viên kết hợp. Tăng liều làm tăng tỷ lệ nồng độ trong huyết tương của bisoprolol fumarate đã được quan sát giữa liều 2,5 mg và 5 mg, cũng như giữa liều 5 mg và 10 mg. Thời gian bán thải T_{1/2} của bisoprolol fumarate trong phạm vi từ 7 giờ đến 15 giờ và hydrochlorothiazide khoảng từ 4 giờ đến 10 giờ. Tỷ lệ phần trăm liều lượng bài tiết trong nước tiểu khoảng 55% đối với bisoprolol fumarate và khoảng 60% với hydrochlorothiazide.

Bisoprolol fumarate

Sinh khả dụng tuyệt đối sau liều uống 10 mg bisoprolol fumarate đạt khoảng 80%. Sự trao đổi chất đầu tiên của bisoprolol fumarate đạt khoảng 20%.

Dữ liệu được đồng học của bisoprolol fumarate đã được kiểm tra sau liều duy nhất và ở trạng thái ổn định. Liên kết với protein huyết thanh khoảng 30%. Nồng độ đỉnh huyết tương xảy ra trong vòng 2 - 4 giờ sau khi dùng thuốc với các liều từ 2,5 mg đến 20 mg và giả trị đỉnh trung bình đạt từ 9 ng/mL ở liều 2,5 mg đến 70 ng/mL ở liều 20 mg. Khi uống bisoprolol fumarate với chuẩn liều một lần mỗi ngày sẽ cho kết quả là nồng độ đỉnh huyết tương ít biến đổi hơn gấp hai lần. Nồng độ tỷ lệ thuận với liều uống trong khoảng từ 2,5 mg đến 20 mg.

Thời gian bán thải của thuốc trong huyết tương khoảng 9 - 12 giờ và hơi dài hơn ở những bệnh nhân cao tuổi, một phần do chức năng thận giảm. Trạng thái ổn định đạt được trong vòng 5 ngày với liều dùng một lần mỗi ngày. Trong cả hai nhóm người trẻ và người cao tuổi, độ tích tụ trong huyết tương thấp, hệ số tích lũy trong khoảng 1,1 đến 1,3, và đây là điều được mong đợi từ thời gian bán thải và dùng thuốc 1 lần/ngày. Bisoprolol fumarate được thải trừ như nhau theo đường thận và không qua thận, với khoảng 50% chất dung xuất hiện trong nước tiểu dưới dạng không đổi và 50% dưới dạng các chất chuyển hóa không hoạt động. Ở người, các chất chuyển hóa được biết đến là không bền hoặc không có hoạt tính dược lý. Có ít hơn 2% liều dung bài tiết qua phân. Các đặc điểm được phân loại của hai đồng phân đối hình (enantiomers) là tương tự nhau. Bisoprolol không bị chuyển hóa bởi enzyme cytochrome P₄₅₀ II D6 (debrisoquin hydroxylase).

Với các độ tương có độ thanh thải creatinine dưới 40 ml/phút, thời gian bán thải trong huyết tương tăng lên khoảng gấp ba lần so với người khỏe mạnh. Ở những bệnh nhân bị xơ gan, tỷ lệ thải trừ bisoprolol thường biến đổi và chậm hơn đáng kể so với độ tương khỏe mạnh, với thời gian bán thải huyết tương trong khoảng 8 - 22 giờ.

Ở những người cao tuổi nồng độ huyết tương trung bình ở trạng thái ổn định được tăng lên, một phần là do độ thanh thải creatinine giảm. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về mức độ tích tụ của bisoprolol được tìm thấy giữa nhóm người trẻ và người cao tuổi.

Hydrochlorothiazide (HCT)

Hydrochlorothiazide được hấp thu tốt (65% -75%) sau khi uống. Sự hấp thu của hydrochlorothiazide giảm ở những bệnh nhân bị suy tim sung huyết.

Nồng độ đỉnh huyết tương quan sát được trong vòng 1-5 giờ sau khi dùng thuốc và nằm trong phạm vi 70 - 490 ng/ml sau liều uống từ 12,5 - 100 mg. Nồng độ trong huyết tương có tính tuyến tính liên quan đến liều dùng. Nồng độ của hydrochlorothiazide trong máu hơn 1,6 - 1,8 lần so với trong huyết tương. Liên kết với protein huyết thanh đã được báo cáo là khoảng 40% đến 68%. Thời gian bán thải trong huyết tương được báo cáo là 6-15 giờ. Hydrochlorothiazide được đào thải chủ yếu bằng đường thận.

Sau liều uống 12,5 - 100 mg, 55% - 77% liều dung xuất hiện trong nước tiểu và hơn 95% của liều hấp thu được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Nồng độ trong huyết tương của HCT gia tăng và thời gian bán thải bị kéo dài ở những bệnh nhân bị bệnh thận.

QUY CÁCH ĐỒNG GỬI

Hộp 03 v x 10 viên

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nhỏ khô, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở

CƠ SỞ SẢN XUẤT



TRÁCH NHIỆM TRỌN VẸN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

(**SaVipharma J.S.C**)

Lô Z01-02-03a Khu Công nghiệp trong Khu Chế xuất Tân Thuận,

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 37700 142 - 37700 143 - 37700 144.

Fax: (84.28) 37700 1415

